

Uzależnienia *behawioralne*

Hazard, gry, pornografia, zakupy, scrollowanie — bez substancji, ale ten sam układ nagrody. ICD-11 i DSM-5 uznają to za pełnoprawne zaburzenia, nie słabość charakteru.

CZAS CZYTANIA: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Griffiths (2005); Potenza (2006, 2008)

JAK UŻYWAĆ

Ten handout to *mapa diagnostyczna*. **1** · Poznasz 6 komponentów uzależnienia behawioralnego (Griffiths). **2** · Zobaczysz, jak działa cykl podtrzymujący zachowanie (Potenza). **3** · Sprawdzisz, na jakim etapie jesteś. **4** · Zrozumiesz, dlaczego mózg *nie odróżnia* wygranej w automacie od dawki narkotyku.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Griffiths (2005) opisał uzależnienie behawioralne (ang. *behavioral addiction*) jako zaburzenie, w którym *zachowanie* — nie substancja — aktywuje układ nagrody i prowadzi do utraty kontroli, kontynuacji mimo szkód i zaniedbywania innych sfer życia. Potenza (2006, 2008) wykazał w badaniach neuroobrazowych, że hazard, kompulsywne granie, pornografia i kompulsywne zakupy aktywują **te same obwody mózgowe** co uzależnienia od substancji: brzuszny obszar nakrywki (ang. *VTA*) → jądro półleżące (ang. *NAcc*) → kora przedczołowa (ang. *PFC*). DSM-5 (APA 2013) wprowadziło hazard patologiczny jako pierwsze uznane uzależnienie behawioralne. ICD-11 (WHO 2019/2022) dodało zaburzenie hazardowe (6C50), zaburzenie związane z grami (6C51) i zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD, 6C72). *Konsekwencja kliniczna:* tolerancja, odstawienie i nawroty występują tak samo jak w uzależnieniu od substancji.

01 Sześć komponentów Griffithsa

Aby zachowanie zostało uznane za uzależnienie, musi spełniać **wszystkie sześć** komponentów. Sprawdź, ile z nich rozpoznajesz u siebie.

1 · DOMINACJA

Zachowanie zajmuje główne miejsce w myślach, planach, decyzjach. „Cały czas o tym myślę.”

2 · MODYFIKACJA NASTROJU

Zachowanie służy regulacji emocji: ulga, pobudzenie, oderwanie. „Bez tego nie umiem się uspokoić.”

3 · TOLERANCJA

Potrzeba **coraz wyższych dawek**: większych stawek, dłuższego grania, ekstremalniejszych treści. „To, co działało rok temu, dziś nie wystarcza.”

4 · ODSTAWIENIE

Gdy nie możesz wykonać zachowania — niepokój, drażliwość, parcie (ang. *craving*), pustka, bezsenność. *Reakcje fizjologiczne*, nie tylko psychiczne.

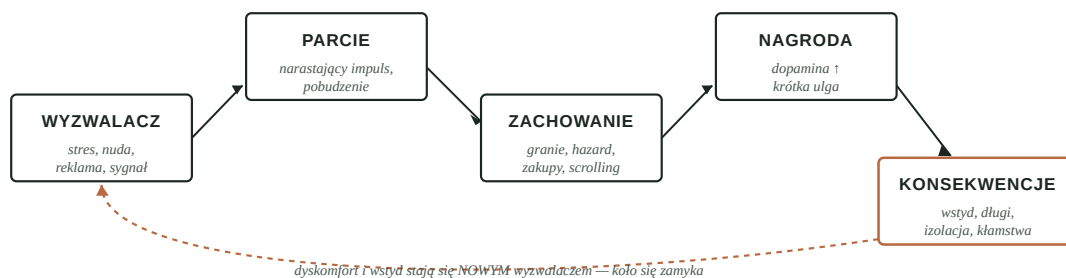
5 · KONFLIKT

Zachowanie wchodzi w kolizję z: relacjami (kłótnie, kłamstwa), pracą (spóźnienia, błędy), finansami (długi), zdrowiem (sen, jedzenie). Wewnątrz: wstyd, poczucie winy.

6 · NAWRÓT

Po okresach abstynencji — powrót do dawnego wzorca. Często szybciej i intensywniej niż wcześniej. „Już raz rzucałem/-am — i wróciłem/-am.”

02 🎯 Cykl podtrzymujący — model Potenzy



Najważniejsza obserwacja: **konsekwencje karmią pętlę**. Wstyd po epizodzie sam staje się wyzwalaczem kolejnego — żeby zagłuszyć dyskomfort. Dlatego sama wola „nie powtórzyć” rzadko wystarcza — trzeba przerwać pętlę w wielu punktach (Potenza 2006; Grant i wsp. 2010).

03 💡 Wspólna neurobiologia — bez substancji, ta sama droga

VTA

brzuszny obszar nakrywki (ang. *ventral tegmental area*)

Źródło dopaminy. Aktywuje się przy wygranej, „prawie wygranej”, oczekiwaniu nagrody. Te same neurony co przy używaniu substancji.

NACC

jądro półleżące (ang. *nucleus accumbens*)

Cel dopaminy — odbiera „nagrodę” i koduje skojarzenie z bodźcem. Tu zapisuje się „*chcę tego znowu*” — niezależnie od tego, czy ma to sens.

PFC

kora przedczołowa (ang. *prefrontal cortex*)

Hamulec — kontrola impulsów, planowanie długoterminowe. W uzależnieniach *osłabiona*. To dlatego „*wiem, że nie powinienem/-am*” nie wystarcza.

Konsekwencja: Twój mózg reaguje na wygraną w automacie albo na powiadomienie w aplikacji *tak samo*, jak mózg osoby uzależnionej od substancji reaguje na dawkę. Dlatego czujesz przymus. Dlatego tracisz kontrolę. **To nie jest słabość charakteru — to neurobiologia.** Volkow i O'Brien (2007): zmiany strukturalne w PFC po przewlekłym wzorcu są *mieralne* w obrazowaniu i odwracalne po 60–90 dniach abstynencji.

04 📋 Mapa diagnoz — co już jest uznane

ICD-11 (WHO 2022)

6C50 — zaburzenie hazardowe (ang. *gambling disorder*)

6C51 — zaburzenie związane z grami (ang. *gaming disorder*)

6C72 — zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD)

DSM-5-TR (APA 2022)

Gambling Disorder — pierwsza uznana behawioralna

Internet Gaming Disorder — w sekcji „do dalszych badań”

Zakupy kompulsywne, kompulsywne jedzenie — bez formalnej diagnozy, ale uznane klinicznie

Klucz: hazard, granie, pornografia, zakupy kompulsywne to *nie „lżejsze” wersje* uzależnienia. To pełnoprawne zaburzenia z udokumentowanymi zmianami w mózgu, kryteriami diagnostycznymi i protokołami leczenia. Najważniejsza wiadomość: **jeśli rozpoznajesz 3+ z 6 komponentów Griffithsa**, to nie jest „brak silnej woli” — to zaburzenie, które wymaga leczenia tak samo, jak uzależnienie od substancji. Skuteczna terapia istnieje (Cowlshaw 2012: CBT, $d=0.74$ dla hazardu).